Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0842470-10.2017.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: Edilza Pereira Villela Vilar
Réu: São Francisco Saúde

Vistos, etc.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral* movida **Edilza Pereira Villela Vilar** em face de **São Francisco Saúde**, ambos já qualificados nos autos.

A parte autora alega que, em abril de 2016, realizou uma cirurgia bariátrica para tratamento de seu quadro de obesidade, procedimento realizado através da empresa ré, no qual é beneficiária como dependente de seu esposo. Conta que, em abril de 2017, fez uma nova cirurgia para a correção do abdômen (Dermolipectomia Abdominal), a qual também estava coberta pelo plano de saúde requerido.

Dando continuidade ao tratamento, informa que entrou com o pedido para realizar a dermolipectomia dos braços e coxas, ante a quantidade significativa de excesso de pele, o que acarretava sobrepeso nos membros superiores e inúmeras dobras na região das coxas, além de mau cheiro e assaduras entre as mesmas.

Afirma, contudo, que a ré negou o seu pedido, sob a alegação de que o procedimento cirúrgico seria de ordem estética, vez que o mesmo não visa restauração parcial ou total da função do órgão ou parte do corpo humano lesionado, por enfermidade trauma ou anomalia congênita.

Salienta que a negativa da ré foi ilícita, e que a situação enseja danos morais.

Requer, assim:

- benesses da justiça gratuita;

- concessão de tutela de urgência, com o fim de que a ré seja condenada a cobrir a continuidade do tratamento médico da requerente, permitindo que sejam realizadas as cirurgias de dermolipectomia de braços e coxas;

- procedência do pedido, sendo ratificada a tutela de urgência e condenando a ré a cobrir a continuidade do tratamento médico da requerente e permitir sejam realizadas as cirurgias de dermolipectomia de braços e coxas;

- condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na decisão de fls. 35/41, foram deferidas as benesses da justiça gratuita e inverteu-se o ônus da prova. Deferiu-se a tutela de urgência pleiteada na inicial e designou-se audiência de conciliação.

Citação e intimação da ré à fl. 56.

À fl. 57, certificou-se que houve a interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão de fls. 35/41, a qual deferiu a tutela de urgência.

Ofício do E. TJMS às fls. 58/64, informando que o recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Termo de assentada à fl. 103, no qual constou que as partes não se compuseram.

A ré apresentou contestação às fls. 104/130, tendo, inicialmente, impugnado o valor da causa, afirmando que a parte autora não comprova que o valor do procedimento cirúrgico seria de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Neste sentido, afirma que o pedido de obrigação de fazer tem caráter ilíquido, não se mostrando razoável indicar valores para o mesmo. Assim, requer que o valor da causa seja reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, alega que o fato da autora necessitar de cirurgias de dermolipectomia de braços e coxas, por si só, não é suficiente para que a ré seja obrigada a custear a cirurgia. Destaca que a requerente não alega qualquer problema de saúde, alegando apenas e tão somente que perdeu peso, o que demanda a realização de cirurgia plástica. Ressalta que a cirurgia solicitada não é reparadora, mas sim estética, o que afasta a obrigação da ré por ausência de cobertura contratual. Afirma, ainda, que a única cirurgia plástica pós-bariátrica reparadora é a dermolipectomia para correção de abdomem em avental, a qual já fora realizada pela ré em abril/2017, conforme reconhecido na inicial. Aduz que a ANS editou a Resolução Normativa 387 n. 167, que definiu e instituiu os procedimentos médicos de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde, determinando, ainda, os procedimentos que podem ser excluídos de cobertura, sendo que a referida resolução excluiu a cobertura para cirurgias estéticas, o que está em conformidade com a Lei n. 9.656/98. Em razão disso, alega que não praticou ilícito, o que afasta a pretensão autoral. Em caso de entendimento diverso, aduz que a situação não gera danos morais, pois tratou-se de mero inadimplemento contratual. Requer a improcedência do pedido.

Réplica às fls. 230/236.

Intimadas a indicarem as provas que pretendiam produzir, a ré pugnou pelo depoimento pessoal da requerente, prova testemunhal e prova documental (fls. 239/240) e a autora quedou-se inerte (fl. 250).

Ofício do E. TJMS às fls. 241/249, no qual informa que fora negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ré, sendo mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Intimadas a indicarem as pontos controvertidos, as partes se manifestaram às fls. 254/255 e 256/257.

Relatados. Decido.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral* movida **Edilza Pereira Villela Vilar** em face de **São Francisco Saúde**, ambos já qualificados nos autos.

O feito admite o julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que a parte autora não manifestou interesse na dilação probatória (fl. 250 e 254/255) e a ré desistiu das provas formuladas anteriormente, nos termos da petição de fls. 256/257, ocasião em que afirma que "*matéria em debate é exclusivamente de direito, estando o feito apto aser julgado no estado em que se encontra*".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.

1 – Da Preliminar de Impugnação ao Valor da Causa

A ré apresentou contestação às fls. 104/130, tendo, inicialmente, impugnado o valor da causa, afirmando que a parte autora não comprova que o valor do procedimento cirúrgico seria de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Neste sentido, afirma que o pedido de obrigação de fazer tem caráter ilíquido, não se mostrando razoável indicar valores para o mesmo. Assim, requer que o valor da causa seja reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. Explica-se.

Conforme determinação expressa do art. 291 do CPC, é sabido que "*a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível*", de modo que todos os pedidos, ainda que ilíquidos, devem ser valorados na inicial, para o fim de fixação do valor da causa.

Partindo dessa premissa, tem-se que, nas ações em que se pretende obrigação de fazer e danos morais, como na espécie, o valor da causa corresponderá a soma dos valores de todos eles, conforme dispõe o art. 292, VI, do CPC.

No que se refere aos danos morais, vê-se que o valor atribuído ao mesmo será equivalente ao montante pretendido (art. 292, V, do CPC), ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme indicado na inicial (fl. 10). Já no que se refere à obrigação de fazer, tem-se que a importância atribuída ao mesmo será equivalente ao valor do ato (art. 292, II, do CPC), que, de acordo com a requerente é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por ser o valor estimado da cirurgia pretendida (fl. 11).

Assim, somando-se tais valores, como mandamenta o art. 292, VI, do CPC, tem-se que o valor da causa será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), exatamente como indicado na inicial.

E ainda que a ré alegue que o valor atribuído ao pedido de obrigação de fazer (cirurgia) está equivocado, não comprova sua alegação, vez que não apresentou ao feito qualquer documento que revelasse qual o montante seria necessária para a realização do ato, de modo que não há elementos nos autos que revelem que houve erro na fixação do valor da causa.

Assim, nos termos do art. 291 c/c art. 292, II, V e VI, todos do CPC, rejeito a preliminar ventilada, vez que correto o valor atribuído à causa.

2 – Do Mérito

2.1 - Da Aplicação das Normas do CDC ao Caso em Apreço

Inexistem dúvidas de que a relação entre as partes no presente feito deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora amolda-se no conceito de consumidora, previsto no art. 2º do CDC, uma vez que é beneficária de plano de saúde fornecido pela requerida, fato este incontroverso nos autos e demonstrado através do documento de fl. 29.

Além disso, como se sabe, os Tribunais já firmaram entendimento no sentido de que as relações contratuais relacionadas à plano de saúde submetem-se às regras previstas no CDC. Neste sentido, permitimo-nos colacionar aos autos o posicionamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.

adotado pelo E. TJMS:

> *"APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INCLUSÃO DA MÃE CURATELADA COMO DEPENDENTE NATURAL NO PLANO DE SAÚDE DA CASSEMS – POSSIBILIDADE – ART. 4º, I, f, DO REGULAMENTO DA CASSEMS – EQUIPARAÇÃO ENTRE TUTELA E CURATELA – INTERPRETAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ART. 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A relação jurídica contratual que tem por objeto o plano de saúde encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJMS – AC 08002924420138120047 – Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho – 3ª Câmara Cível – Julg. 02/03/2016)."*

Assim, ante o exposto, tem-se que a presente demanda deverá ser analisada sob a égide do CDC.

2.2- Da Alegada Conduta Ilícita da Requerida (Negativa de Cobertura) e Dos Danos Morais

A Constituição Federal de 1988, ao fixar os direitos e garantias fundamentais, instituiu o direito à indenização por danos morais ao determinar em seu art. 5º, incisos V e X:

> *"V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;"*
> *"X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"*

Regulamentando tal direito, estabelecem os artigos 186 e 187 do Código Civil:

> *"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."*
> *"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.

costumes."

Complementando a norma, o art. 927 do Código Civil prescreve:

> *"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."*

Desse modo, conjugando tais dispositivos, aquele que causar dano a outrem, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repara-lo.

Entretanto, é certo que para vislumbrar tal responsabilidade é imprescindível a coexistência de três elementos fundamentais, quais sejam, o dano sofrido pela vítima, a conduta ofensiva praticada pelo agente e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta praticada.

Partindo dessa premissa, vê-se que o presente caso trata-se de análise de suposta responsabilidade da requerida pela negativa de tratamento médico à requerente, titular de plano de saúde comercializado pela ré.

Neste sentido, vê-se que autora, a qual apresentava quadro clínico de obesidade mórbida e foi submetida à cirurgia bariátrica, tendo a requerida efetuado o pagamento integral de tal procedimento, fato este não impugnado pela ré, tornando-se pois, incontroverso, nos termos do art. 341, do CPC.

Em sequência, ante o excesso de pele na região abdominal, a autora foi submetida à nova cirurgia denominada "Dermolipectomia de Abdômen pós Bariátrica", procedimento este que também fora custeado pela ré, fato este incontroverso nos autos.

Consta, ainda, que, após a realização das referidas cirurgias, a médica da requerente (Dra. Lilian de Oliveira Miranda - CRM 4296 - MS) a encaminhou para o procedimento cirúrgico denominado "Dermolipectomia de coxa e dermolipectomia de braço" (retirada de excesso de pele), conforme laudo de fls. 30/31 e guia de solicitação de fl. 32, tendo a ré negado tal pleito, sob a justificativa de que tal procedimento teria natureza estética, o que não está coberto pelo plano de saúde, conforme documento de fl. 29:

6) Motivos da Negativa de Autorização do Acesso ou Cobertura:

O procedimento ou serviço (acima especificado no item 4) solicitado pelo beneficiário (acima referenciado no item 1) através do protocolo (acima registrado no item 3) não foi autorizado porque o contrato de seu plano de saúde é regulamentado e a operadora apenas tem obrigação legal de garantir procedimentos e serviços previstos na Lei nº 9.656, de 1998, e em seus regulamentos. E, neste caso, sua solicitação não está prevista na Lei 9656/98 ou no Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nem das eventuais cláusulas adicionais de seu contrato.

Cláusula contratual:	**CLAUSULA 4.1 / ITEM D - Exclusão Contratual para procedimentos clínicos ou cirúrgicos de ordem estética que não visam restauração parcial ou total da função do orgão ou parte do corpo humano lesionada, por enfermidade, trauma ou anomalia congênita.**

Seguindo as regras de distribuição do ônus probatório, previstas no art. 373, do CPC, tem-se que caberia à requerida demonstrar nos autos a legalidade de sua conduta, ou seja, evidenciar que a negativa de cobertura foi lícita, e de acordo com a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.

legislação em vigor, **o que não ocorreu.**

Neste sentido, frisa-se, de início, que, os Tribunais tem adotado o entendimento de que as cirurgias atinentes à completa restauração da saúde do paciente acometido de obesidade mórbida devem ser cobertas pelo plano de saúde, não apenas a cirurgia bariátrica, **como também as cirurgias de dermolipectomia (seja a de abdômen ou de outras partes do corpo), eis que não se tratam de cirurgias estéticas, mas sim de caráter reparador, desde que haja prescrição médica para tanto.**

É o que diz o E. TJMS:

> *"APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA PLÁSTICA PARA RETIRADA DE EXCESSO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A cirurgia plástica para retirada de excesso de pele após emagrecimento acentuado decorrente de intervenção cirúrgica para tratamento de obesidade mórbida não tem caráter meramente estético e sim reparador, pois visa restabelecer o bem físico e psicológico do paciente, e deve ser considerada como extensão da redução de estômago (TJMS – AC 0001831-04.2010.8.12.0041 – Des. Marcelo Câmara Rasslan – 1ª Câmara Cível – Julg. 05/09/2014).*

Extrai-se, portanto, que sendo a cirurgia de dermolipectomia (frise-se, em qualquer parte do corpo: abdômen, coxas, bracos e etc) é mera integrante do tratamento da obesidade mórbida, impõe-se ao plano de saúde oferecer tal tratamento aos seus associados, desde que haja prescrição médica, o que se verificou na espécie.

Veja-se que a parte autora, em 09/10/2017, *através de solicitação de médico, devidamente registrado junto ao CRM (Dra. Lilian de Oliveira Miranda)* – fls. 30/31, foi encaminhada para o procedimento cirúrgico denominado "*Dermolipectomia de Coxas e Braços pós Bariátrica*", conforme guia de solicitação de internação de fl. 32, tendo a ré negado tal pleito, conforme notificação de fl. 29.

Além disso, através da análise do pedido de internação de fl. 30/31, trazida aos autos pela autora e não impugnada pela ré, vê-se que *a médica Dra. Lilian de Oliveira Miranda - CRM 4296 explicou os motivos pelo qual estava encaminhando a autora para procedimento cirúrgico de Dermolipectomia de Coxas e Braços pós Bariátrica fundamentando-o nos seguintes termos:*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

A paciente Edilza Villela Vilar, 50 anos, foi submetida em abril de 2016 à Cirurgia Bariátrica para tratamento do quadro de obesidade e de todas as comorbidades advindas. Relata ter perdido 60kg. Em abril do presente ano(2017), já fez a correção do excesso de pele de abdome(Dermolipectomia Abdominal), subsidiado pelo convênio da paciente, conforme me relata. Essa cirurgia é apenas uma a que os pacientes pós-bariátricos precisam ser submetidos. Há muitas vezes excesso de pele em braços, coxas, pescoço, face.

Na referida paciente há excesso de pele em quantidade significativa em braços e coxas. Nos braços há cerca de 10cm de excesso de pele, o que inviabiliza a paciente usar muitas roupas, visto que o braço tem mais pele(portanto mais grosso em diâmetro) que o antebraço. Muitas vezes a roupa serve até o cotovelo(final do antebraço), mas não passa pelo braço.

Em relação às coxas, o caso é ainda mais alarmante. O excesso de pele chega a fazer inúmeros dobras, com mal cheiro e assaduras entre as mesmas, além de apresentar à palpação um peso significativo(talvez alguns quilos de pele), isso em cada coxa. Além disso o contato do excesso de pele com o intróito da uretra, pode ser causa de infecções urinárias de repetição que a mesma apresenta. Há ainda sinais de micose em região inguinal.

Ambos os procedimentos são essencialmente reparadores, chamados de Dermolipectomia de Coxa e Dermolipectomia de Braço.

O caso é tão preocupante, que talvez seja necessário realizar o procedimento em coxa em duas etapas, pois devido à quantidade de tecido, há risco de sangramento importante, o que pode impedir que toda a pele seja retirada de uma só vez. Há indicação inclusive de reserva de sangue para a paciente e de vaga no CTI para o pós operatório imediato.

Apesar dos riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, ainda vislumbro benefício para a paciente, pois além dos motivos elencados acima, a paciente não consegue usar calças e apresenta quadros patológicos diretamente relacionados ao excesso de pele(infecções de pele, micose, infecção urinária)

Dessa maneira, há indicação de realizar a Dermolipectomia de Coxas e Braços. Além disso, é essencial que a cirurgia seja realizada sob as seguintes condições:

Assim, não há como se admitir a negativa da requerida em oferecer tal tratamento à requerente, uma vez que o mesmo foi prescrito por médico, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, restando patente a ilegalidade da requerida.

E embora a ré alegue que negou o pleito com base no contrato firmado entre as partes e com base nas normativas da ANS, tem-se que seu pleito não merece acolhimento.

Isso porque, além da Dermolipectomia ser um dos tratamentos para a patologia obesidade mórbida (doença esta que a requerente apresentava, conforme laudo de fl. 30/31, não impugnado pela ré), **vê-se que tal procedimento cirúrgico está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, conforme Anexo I, da Resolução 338/13, se enquadrando em uma das coberturas mínimas obrigatórias a serem garantidas pelos planos de saúde comercializados, não havendo razão, portanto, para que seja negado o referido tratamento à requerente.**

Neste sentido, permitimo-nos colacionar aos autos, as informações retiradas do próprio site da Agência Nacional de Saúde - ANS (http://www.Ans.gov.br/):

> *"COBERTURA – DERMOLIPECTOMIA: A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS estabelece um Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente vigente por*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.

> *intermédio da Resolução Normativa nº 338/2013, alterada pela RN nº 349/2014, que constitui a cobertura mínima obrigatória a ser garantida pelos planos de saúde comercializados a partir de 2/1/1999, bem como para aqueles contratados anteriormente, desde que adaptados à Lei 9656/1998, nos termos do artigo 35 da referida Lei e respeitadas as segmentações assistenciais contratadas;*
> ***O procedimento "DERMOLIPECTOMIA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)" foi incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde por ocasião da edição da Resolução Normativa – RN – 167/2008.*** *Nesta RN o procedimento denominava-se DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDOME EM AVENTAL APÓS TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA (DE ACORDO COM A DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO). No entanto, com a edição da Resolução Normativa 262/2011 que alterou a Resolução Normativa 211/2010 passou a denominar o procedimento de "DERMOLIPECTOMIA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)".*

Ou seja, a normativa não determina que apenas a dermolipectomia de abdôme seja admitida pelo plano de saúde, mas qualquer uma que seja indicada pelo médico como necessária ao tratamento da paciente. **E, ainda que não fosse, tem-se que o rol de procedimento trazidos pela ANS não é taxativo, mas sim exemplificativo, de modo que não há óbice para a realização do procedimento pela ré.**

Ressalta-se que, além da dermolipectomia estar incluída no rol de procedimentos da ANS (que determina quais são as patologias com cobertura obrigatória), as circunstâncias do caso concreto atendem aos requisitos exigidos pelo Item 17, do Anexo II, da Resolução 338/ANS (Diretriz de Utilização - DUT), quais sejam:

> "17. DERMOLIPECTOMIA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)" 1. Cobertura obrigatória em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de **grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago**), e apresentem uma ou mais das seguintes complicações: candidíase de repetição, **infecções** bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido, hérnias, etc."

Ao observar a solicitação de fls. 30/31, assinada pelo médico da autora, verifica-se que a requerente foi encaminhada para o procedimento cirúrgico de dermolipectomia de coxas e braços (redução de excesso de pele), **porque era paciente pós operatória bariátrica, apresentava excesso de pele em quantidade significativa em braços e coxas, e ainda, estava desenvolvendo mal cheiro e assaduras e infecções de pele e urinárias de repetição, já existindo sinais de micose na região inguinal,** exatamente nos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.

moldes descritos no Item 17, do Anexo II, da Resolução 338/ANS (Diretriz de Utilização - DUT), não havendo óbice para a autorização do tratamento, por parte da requerida.

Ademais, o laudo psicológico de fl. 20/21, datado de 24/11/2017, emitido por psicólogo devidamente registrado no CRP, também revela a necessidade do procedimento cirúrgico de dermolipectomia de braços e coxas para a continuação do tratamento da requerente:

> *"(...) A paciente encontra-se apta a fazer a cirurgia de reconstrução de excesso de pele, pois a família está motivando e ela se encontra em condições físicas através de exames médicos realizados, precisa fazer para que os problemas que vem apresentado como assaduras, linfomas, infecção urinária e psicológica seja reestruturada".*

Dessa forma, houve ato ilícito por parte da ré, a qual, em descumprimento ao contrato firmado entre as partes e em descumprimento à Resolução 338/ANS e ao parecer de médico especialista, deixou de oferecer tratamento médico à requerente (dermolipectomia de braços e coxas), **sendo inclusive este o entendimento do E. TJMS quando da análise do agravo de instrumento interposto pela ré, conforme ofício de fls. 241/249, de modo que impõe-se a procedência do pedido de obrigação de fazer.**

Ademais, restam, portanto, indubitavelmente demonstrados os elementos caracterizadores da obrigação de indenizar, quais sejam, uma ação ou omissão voluntária, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pelo ofendido.

Vale reforçar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente feito é medida que se impõe, vejamos:

> *"Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final", enquanto que o art. 3º disciplina que fornecedor "é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."*
> *"Art 3º. (...)*
> *§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.*

Então, não há dúvidas de que as atividades desenvolvidas pelo réu estão inseridas no conceito legal de serviços e, por isso, deve ser aplicado, no caso, a regra disposta no art. 14 do CDC, que prevê a teoria do risco do empreendimento:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.

> *"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.*
> *§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:*
> *I – o modo de seu fornecimento;*
> *II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;*
> *III – a época em que foi fornecido".*

Por essa teoria, os planos de saúde, como é o caso da parte requerida, respondem objetivamente na hipótese de, pela falta de cautela em seus procedimentos, gerar um prejuízo ao consumidor.

Portanto, consoante disposto no art. 14 do CDC, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços terá o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

No caso vertente, como dito alhures, não há como deixar de reconhecer a imprudência e a negligência da parte requerida que negou tratamento médico à requerente, desrespeitando o negócio jurídico firmado entre as partes (plano de saúde), bem como, desobedecendo as normas aplicadas à referida relação, quais sejam (CDC e Resolução 338/ANS).

O dano moral também resta evidente nos autos, na medida que são públicos e notórios os constrangimentos impostos àqueles que porventura tenham procedimentos médicos ou cirúrgicos negados pelo plano de saúde, capazes de gerar angústia, preocupação e humilhação, interferindo de maneira direta na normalidade das relações experimentadas pelo consumidor.

Ora, a partir do momento que a parte autora se associa à plano de saúde e efetua o pagamento do mesmo de maneira pontual, é certo que cria expectativa, no sentido de que terá atendimento médico eficiente, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que a requerida, em total descumprimento à previsão legal (Item 17, Anexo II, Res. 338/ANS), negou procedimento cirúrgico à requerente, o que indica que a conduta ilícita da ré não configurou mero aborrecimento.

É o que diz o E. TJDF:

> *"CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELÉ. FINALIDADE REPARADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPRÓVIDO. 1. Apelação contra*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.

sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, direcionada a obter autorização para a realização de cirurgia reparadora (plástica) e indenização por danos morais. 2. É ilegítima a recusa da cobertura securitária para cirurgia plástica de retirada de excesso de pelé pós-bariátrica, por não se tratar de procedimento meramente estético, mas sim funcional e reparador, sendo mera continuidade do tratamento iniciado com a realização da bariátrica. 2.1. Precedente da Turma: "(...) 3. A cirurgia plástica para redução de tecido, pós-cirurgia de redução de peso, a toda evidência não se trata de procedimento meramente estético, mas sim, essencialmente reparador, com finalidade de melhora funcional da qualidade de vida do paciente, revelando-se abusiva qualquer cláusula contratual tendente a limitar o tratamento médico integral inicialmente prestado pela operadora do plano de saúde". (20130510106334APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2ª Turma Cível, DJE: 17/03/2015). 3. Aatitude da operadora do plano de saúde, ao recusar a cobertura do procedimento cirúrgico, apesar da constatação médica da necessidade, violou direitos de personalidade da demandante, ao frustrar suas expectativas de receber a devida cobertura securitária para ter recuperada a sua saúde. 3.1. Precedente da Turma: "2. É desnecessária a qualificação do sofrimento suportado pelo paciente que se vê diante da recusa de autorização para realizar procedimento médico necessário e indicado por profissional, casos nos quais o dano moral é presumido, caracterizando-se na modalidade in re ipsa". (20140910215722APC, Relator Designado: Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, DJE: 04/08/2015). 4. O percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença é compatível com os atos processuais realizados, com a natureza e importância da causa, com o trabalho realizado pelo advogado e com o tempo despendido para o seu serviço, estando em consonância com o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil. 5. Recurso improvido (TJDF – AC 20150110214037 – Rel. Mário Zam Belmiro – 2ª Turma Cível – Julg. 02/03/2016).

Em relação ao *quantum* indenizatório, é cediço que a fixação dos danos morais deve obedecer aos critérios da solidariedade e exemplaridade, que implica a valoração da proporcionalidade do quantum e a capacidade econômica do sucumbente.

Dessa forma, observando os precedentes judiciais e examinando as peculiaridades do caso em tela, com a atenção voltada à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida, entende-se como suficiente o valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais).**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

O valor da indenização deverá ser atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do seu arbitramento, consoante enunciado da Súmula 362 do STJ (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento). Os juros de mora, no caso de dano moral, como é o presente, são devidos a partir da data da citação, nos termos do art. 405, do CC/02, por tratar-se de responsabilidade contratual.

Dispositivo

Posto isto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo, com resolução do mérito, **PROCEDENTES** os pedidos formulados por **Edilza Pereira Villela Vilar** nesta AÇÃO movida em face de **São Francisco Saúde**, para o fim de:

I) obrigar a ré a dar continuidade ao tratamento médico da autora, no sentido de autorizas que a mesma realize as cirurgias de Dermolipectomia de Braços e coxas, conforme orientação medica de fls. 30/31, **restando ratificada a tutela de urgência concedida às fls. 35/41;**

II) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do seu arbitramento, consoante enunciado da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora são devidos a partir da data da citação, nos termos do art. 405, do CC/02, por tratar-se de responsabilidade contratual.

Ante a sucumbência da ré, condeno esta exclusivamente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 30/01/2020 às 16:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842470-10.2017.8.12.0001 e código NSQYKMd1.